



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : امل احمد عبدالحى سيد
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : العمرانية
رقم البطاقة : 27408090103602 رقم التليفون : 01254566565
العمر (تاريخ الميلاد) : 09-08-1974 المهنة : حاصل علي دبلوم
العنوان : -----
تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: امل احمد عبدالحى سيد National ID: 27408090103602	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٣٣/١٠
٢٧٤٠٨٠٩٠١٠٣٩٠٢
حاصلة على دبلوم تجارة
مترجمة
مسجلة
التي
جاءت من صندوق أبو الجوز
البنك سارية حتى ٢٠٣٠/١٠/٢٩



الاسم
أحمد عبد الله سيد احمد
١٣ من الجاهل - الطائفة
المرتبعة - الجوز

٢٧٤٠٨٠٩٠١٠٣٩٠٢

KF8609703

Patient Name	امل احمد عبدالحى	Age	51
Sex	F	Special habits	
Family History		Comorbidity	-ve
Surgical History		Telephone	01151440390 01148957647
Menopausal Status	post	Marital Status	
ID	27408090103602	Medical ID	469/2025
Date	9-11-2025	Reason of MDT	

Medical Report

Pathology: ILCS
ER: 8/8 PR: 8/8 HER2: +3
Ki67: 15%

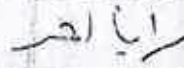
MDT

NACT : TCHP x6 cycles
Post Lt MRM
DCIS: absent, Nipple & areola: free, Deep margin: free
Axilla: 0/10
T1N0

Doctor's notes:

Recommendations :

MDT DECISION	For:adjuvant kadcylla x 12 Arimidex , PORT
--------------	---

Name	حنان عزت	رائيا شفيق	احمد نجيب
Signature			

Patient Name : الأستاذ / أمل احمد عبدالحى سيد
Patient No. : 27408090103602
Path No. : 3137/25
Sex : Female
Age : 51 Y
Referring Doc :

Request No. : 13006242
Request Date : 14/10/2025
Verification Date : 22/10/2025
Financial Category : جوسفار رومى - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post-NACT.
Nature of specimen: Left modified radical mastectomy.

Gross Examination:

- * Left modified radical mastectomy specimen measured 20x18x5 cm, with covering skin ellipse measured 15x10 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.
- * Serialling showed a tumor bed site measured 9x8x3 cm, located 2 cm away from the deep margin.
- * Axilla: Axillary fat measured 8x7x2 cm, entangling 10 lymph nodes, the largest was 1.5x1x0.5 cm.
- 15 Blocks:
- 1:9- T.B.S., 10- N&A., 11- Deep margin., 12:15- ALNs.
- Gross was done by; Dr.Heba Hassan.

Microscopic examination:

- * Histological type: Residual viable invasive lobular carcinoma (Actual tumour size 0.9x0.9 cm) (Cellularity 2%).
- * Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Lobular carcinoma in situ: Focal.
- * Microcalcification: Present.
- * Angiolinvasion: absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * Additional findings: Multiple intra-ductal papillomas.
- * Nipple and areola: Free.
- * Deep margin: Free.
- * Axillary lymph nodes: Ten lymph nodes free of viable metastatic deposits, (0/10) (Four lymph nodes showing effect of therapy).

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 26/10/2025 08:34:50

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy

CAP
ACCREDITED

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأمتالة / أمل احمد عبدالحى سيد	Request No. : 13006242
Patient No. : 27408090103602	Request Date : 14/10/2025
Path No. : 3137/25	Verification Date : 22/10/2025
Sex : Female	Financial Category : جوسفاف روسي - نفقة الدولة
Age : 51 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

• Histologic response to therapy: Pathologic partial response to therapy.

Diagnosis:

Left breast cancer (Post-NACT), Left modified radical mastectomy:

Residual viable Invasive lobular carcinoma, Grade 2 (Cellularity 2%) (Actual tumor size 0.9x0.9 cm).

* DCIS: Absent.

* Nipple and areola: Free.

* Deep margin: Free.

* Axillary lymph nodes: Ten lymph nodes free of viable metastatic deposits, (0/10) (Four lymph nodes showing effect of therapy).

* Stage: ypT1b, ypN0.

* RCB:1.532, RCB class-II.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonelm.

Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 26/10/2025 08:34:50

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy

Patient Name: Amal Ahmed Abd Al Hai Sayed	Date : 21/09/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 469/2024	Pat. ID: 98313

BILATERAL MAMMOGRAM AND BREAST ULTRASONOGRAPHY REVEALED:

Indication: Follow up after neoadjuvant chemotherapy of pathologically proved left breast carcinoma.

- **Breast density:** Extreme dense breast . Breast density matches ACR C.
- **Focal asymmetry and architectural distortion is seen in the left UOQ with grouped microcalcifications in the left UOQ .extending for distance of 3 cm .**
- No detected suspicious mass density, architectural distortion or pathological micro-calcification in the right breast.
- Normal right skin and nipple.

By complementary breast ultrasound:

- **An area of architectural distortion is seen in the left breast in-between 12-2 o'clock position, involving zones 1 &2 .**
- **Few (about 3 in number) irregular shaped masses are seen in the left breast at 12 o'clock ,zone measuring (9x 6 mm) and at 1 o'clock (zone 1 measuring (16 x 7 mm) and at 2 o'clock ,zone 1 measuring (8 x 4 mm).**
- **The previously described right 12oclock lesion measures (9.5 x 7 mm).**
- **No detected suspicious masses in the right breast .**
- **One residual indeterminate nature left axillary lymph node ,it measures (21 x 14.5 mm) with thick cortex of 4 mm ..**

Conclusion:

- Comparing to the previous radiological datafindings are suggestive of partial radiological response (PR)(BIRADS 6 category).
- Right UOQ probably benign looking lesion (BIRADS 3 category).

Much Obliged

DR.MONA ZAKY.MD

professor-Breast imaging-Mansoura university

Signature Dr. Mona Zaki



Patient Name: Amal Ahmed Abd Al Hal Sayed	Date : 10/03/2025
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 50 Year(s)
Medical ID: 469/2025	Pat. ID: 98313

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

↓ Reported case of left breast cancer

Findings:

I Chest:-

- Enlarged left axillary lymph nodes, the largest measures about 2.2x1.7cm at level I.
- Fewv right tiny pulmonary nodules , the largest measures about 2 mm at lateral basal segment of right lower lobe
- Promenant mediastinal lymph nodes the largest is measures about 0.7mm.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definte focal lesions (on non contrast base) or contour irregularities.
- No Intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Evidence of multiple hyperdense gall blader stones.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with kleft renal stone , no back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with basal single hyperdense stone measures about 11 mm, no diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:**

- Sclerotic foci are seen at D5&4 vertebral bodies → free

Opinion:

- Right tiny pulmonary nodules as described, for follow up.



Patient Name: Amal Ahmed Abd Al Hai Sayed	Date : 10/03/2025
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 50 Year(s)
Medical ID: 469/2025	Pat. ID: 98313

- Calcular gallbladder , as well as kidney and urinary bladder stones.
- Sclerotic foci are seen at D5&4 vertebral bodies for bone scan.
- No evidence of hepatic focal lesions on noncontrast basis.

Dr. Khawla Ahmed

Prof. Menna Talla Hanafy, M.D.